

SEMIOLÓGIA EN CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL PAC Y URGENCIAS: EXPLORACIÓN FÍSICA Y RADIOLOGÍA

Pedro Martínez Seijas, Jorge Arenaz Búa, Antonio Cuesta Ramos.

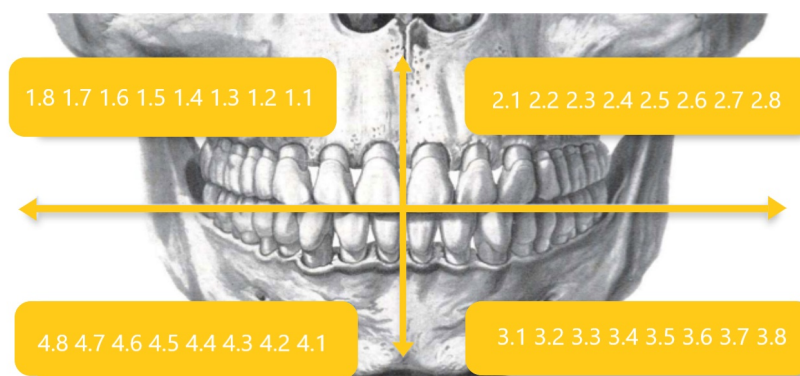
INTRODUCCIÓN

El área Oral, Maxilofacial y Cervical es de fácil acceso para la inspección, exploración (física y radiológica) con la semiología propia de esta región.

Para realizar la exploración es necesaria una buena iluminación y una buena aspiración.

Conceptos básicos:

- **Tumoración:** todo aumento de tamaño en los tejidos de forma localizada o no localizada.
 - **Tumefacción:** toda tumoración con signos de Celsius.
- **OJO:** “BULTOMA” Es un neologismo que es erróneo, pues no permite discriminar ni orientar hacia la posible etiología, por ello se debe evitar usar.
- **Oclusión dental:** forma de cerrar los dientes.
 - **Impotencia funcional:**
 - Apertura y cierre mandibular y morder con los dientes.
 - MOE (movimientos oculares extrínsecos). Diplopía.
 - **Fórmula dentaria adulta** y anotación dentaria Federación Dentaria Internacional (FDI) (1):



Anamnesis

Preguntas clásicas ¿Qué le ocurre?, ¿Dónde le duele? ¿Desde cuando?, ¿Cómo? y ¿A qué lo atribuye?.

Preguntas para urgencias en Cirugía Oral y Maxilofacial:

- ¿Puede abrir la boca?: si no puede TRISMUS (signo importante)

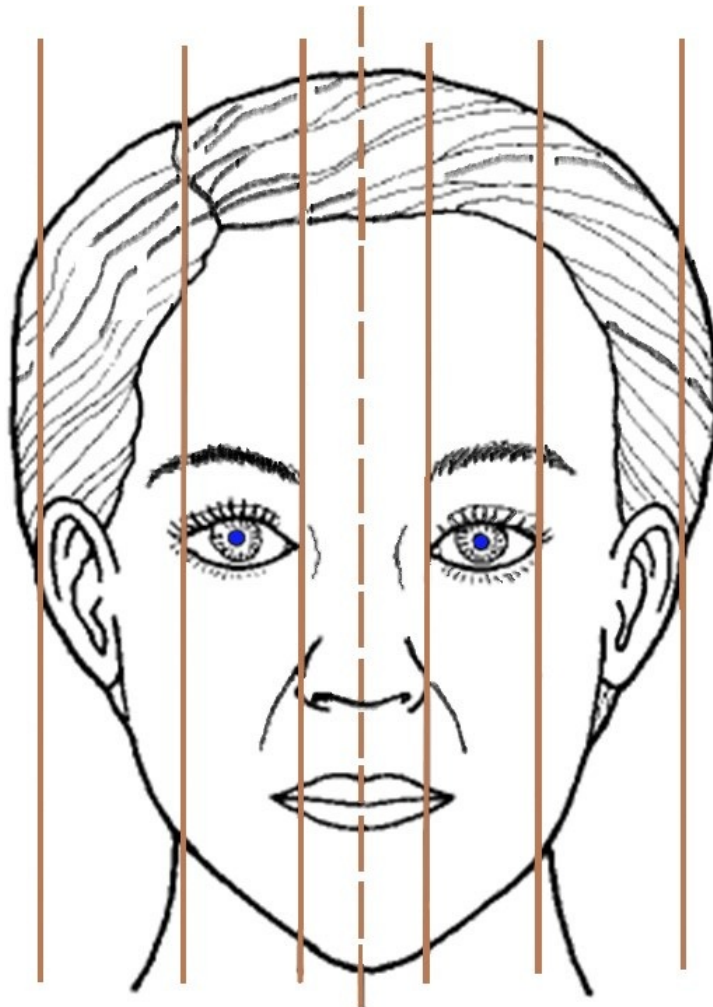
- ¿Nota que muerde como antes del traumatismo?: No muerde como antes (oclusión alterada) sospechar FRACTURA.
- ¿Puede cerrar la boca?: No puede sospechar una LUXACIÓN MANDIBULAR.
- ¿Qué diente es el que le duele o cuáles le duele?: Buscar el “DIENTE PROBLEMA”.
- ¿Ve doble?: En caso afirmativo FRACTURA o HEMATOMA ORBITARIO.
- ¿Nota fiebre y/o escalofríos?: Sospecha de INFECCIÓN.
- ¿Tiene dolor al tragar?, ¿Nota cambios en el tono al hablar como “si tuviera una patata caliente en la boca”: Sospecha de infección oral y cervical.

Inspección

Realizarla de forma ordenada y por regiones.

Signos de Celsius: inflamación-infección: rubor, tumor, calor y dolor.

- **Facial:**
 - Valorar simetrías y asimetrías agudas..
 - Prognatismo (mandíbula adelantada al maxilar).
 - Retrognatia (mandíbula retrasada al maxilar)
 - Laterognatia (mandíbula ladeada a derecha o izquierda)
 - Desviación de la mandíbula durante la apertura oral.
 - Localización de heridas y hematomas (lugar de traumatismos primarios y secundarios).

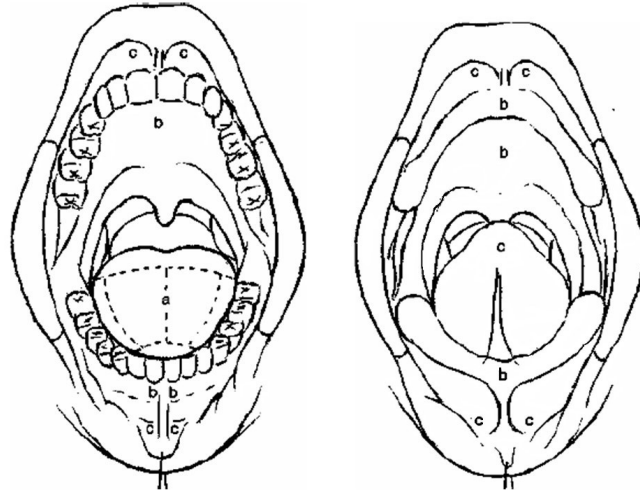


Tumefacciones (inflamaciones localizadas o no localizadas) o tumoraciones.

- **Orodental:**

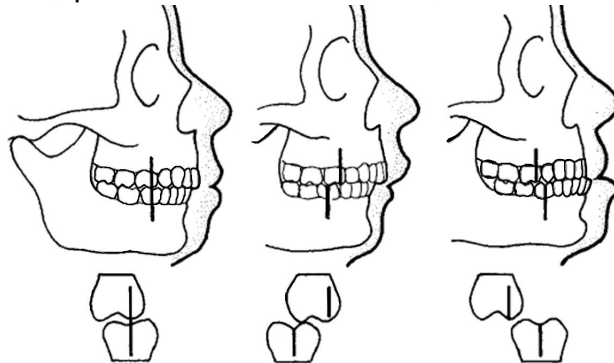
- **Mucosas.**

- Hematomas y/o heridas.
 - Tumefacción (inflamación y su relación con los dientes cercanos)
 - Tumoración.



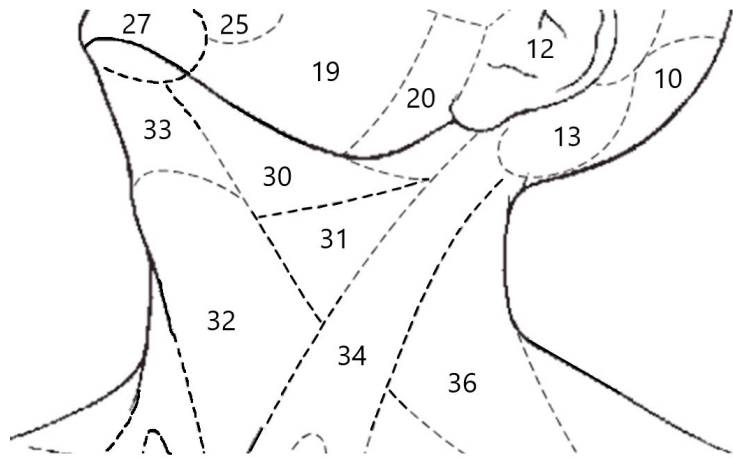
- **Dientes.**

- Fórmula dentaria por arcada Formula dental internacional (FDI):
 - 2 Incisivos, 1 canino, 2 premolares, 3 molares.
 - Dientes íntegros, con obturaciones (empastes) y/o caries.
 - Oclusión dental (clasificación de Angle).
 - Oclusión clase I normal.
 - Oclusión clase II. ("retrusión mandibular").
 - Oclusión clase III. ("protrusión mandibular").



- **Cervical.** Exploración por regiones

- Heridas, hematomas y hemorragias.
 - Tumoración.
 - Tumefacción.



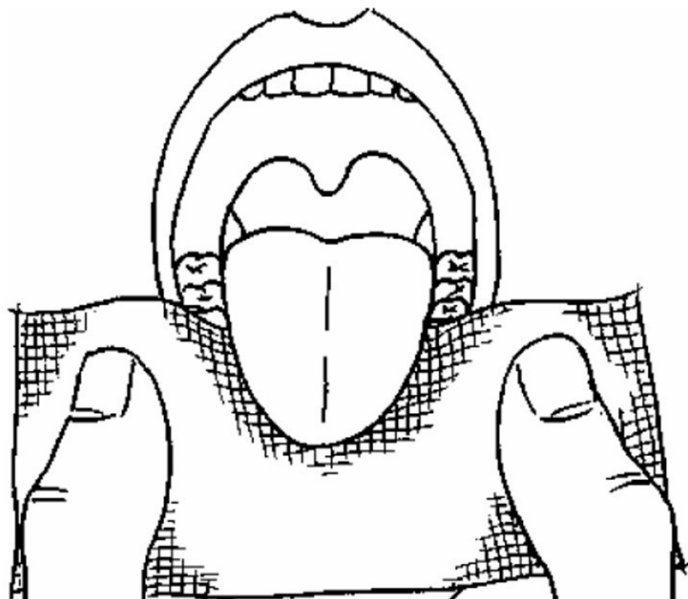
Exploración física

Signos de Celsius inflamación-infección: Rubor, Tumor, Calor y Dolor.

Impotencia funcional.

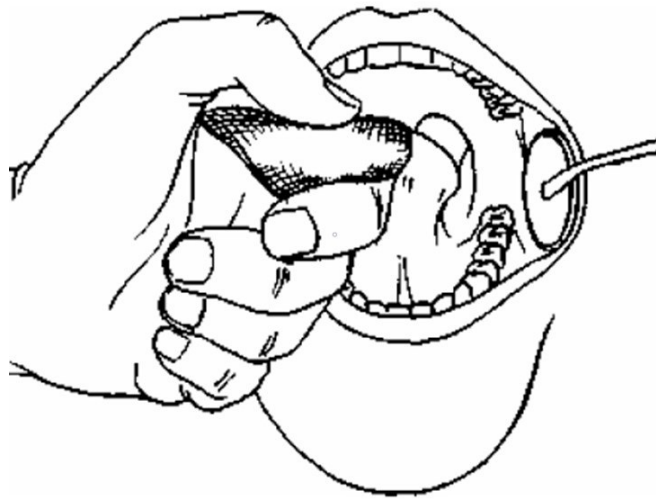
- **Facial:**

- Palpación. Durante la exploración la palpación la realizamos bimanual y de forma simétrica para realizar comparaciones. Mediante la exploración buscamos escalones, tumoraciones, tumefacciones, crepitación, movilidad ósea anormal



- **Oral y dental:**

- **Oral.** Realizamos palpación de la cavidad oral de forma sistematizada y con control visual.
 - Comenzamos por el vestíbulo bucal superior derecho para ir progresando en dirección a las agujas del reloj.
 - Luego ambas mucosas yugales: a nivel del 2º molar superior (17 y 27)



- Seguimos por la lengua: punta, bordes laterales derecho e izquierdo, base de lengua, caras ventrales linguales derecha e izquierda.



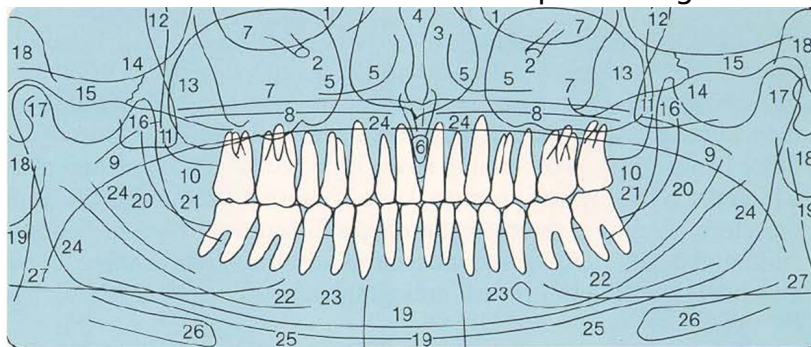
- Suelo de boca: a ambos lados del frenillo lingual se aprecia la salida de ambos conductos de Wharton y en el surco gloso-mandibular se encuentra la glándula sublingual. Se realiza palpación bimanual con el índice en suelo de boca y con la mano contraria en la región submaxilar. Tumefacción, tumoración (litiasis conducto de Wharton).
- Paladar duro y paladar blando. Su palpación nos da información acerca de tumefacciones y tumoraciones.
- Región del triángulo retromolar, pilar amigdalino y amígdala.
- **Dental y alveolar.**
 - **Dental:** Movilidad de los dientes. Dolor a la percusión de los dientes que puedan ser sospechosos (la percusión suave pues puede desencadenar dolor importante).
 - **Proceso alveolar** en la vertiente vestibular y lingual: tumefacción, abscesos, salida de secreciones por el periodonto.

- **Cervical:**

- La palpación la realizaremos también de forma sistematizada, primero un lado y luego el otro. Tumefacción, dolor o tumores. Adenopatías.

Exploración radiológica complementaria

- **Ortopantomografía.** Estructuras visibles en la ortopantomografía.



1 Orbita

2 Agujero infraorbitario

3 Cavidad nasal

4 Tabique nasal

5 Cornete inferior

6 Agujero interincisal

7 Seno maxilar

8 Apófisis palatina maxilar

9 Paladar blando

10 Tuberosidad maxilar

11 Apófisis pterigoides

12 Fosa pterigopalatina

13 Hueso malar

14 Sutura temporo-malar

15 Arco Cigomático y Tubérculo

16 Apófisis Conoides

17 Cóndilo

18 CAE

19 Vertebra cervical

20 Cresta temporal en la mandíbula

21 Línea oblicua mandibular

22 Conducto nervio dentario

23 Agujero mentoniano

24 Dorso de lengua

25 Borde inferior mandibular

26 Hueso hioides

27 Superposición de la mandíbula contralateral

Semiología

- Lesión excrecente o ulcerada y/o adenopatía cervical y/o odinofagia de 15 días de evolución o un mes. Remitir a CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL para su valoración.
- Luxación mandibular. Incapacidad para cerrar la boca, suele estar desviada hacia el lado contrario a la luxación cuando es unilateral, que es la más frecuente.
- Fractura o artritis traumática de ATM: Cambios oclusales, limitación de la apertura oral con dolor, desviación mandibular hacia el lado fracturado.
- Infección oral y cervical: Trismus, odinofagia, cambios en la dicción “patata caliente en la boca”, con o sin fiebre. URGENCIA VÍA AEREA POR TUMEFACCIÓN ORAL Y CERVICAL.
- Síndrome orbitario agudo: Proptosis, Oftamoplegia, disminución de la agudeza visual o pérdida de la visión, edema palpebral, conjuntival y orbitario hipoestesia corneal.
- Tumefacción aguda región submandibular o parotídea durante la ingesta: sospecha de

cólico de glándula submaxilar o glándula parotídea.

BIBLIOGRAFÍA

- Wheeler. Anatomía, fisiología y oclusión dentaria. Saunders. 2004.
- Cirugía Oral y Maxilofacial. Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial. A. López Davis. R. Martín Granizo. Ed. Panamericana. 2012. ISBN: 978-84-9835-271-9.
- Alex M. Greenberg. Craniomaxillofacial Reconstructive and Corrective Bone Sugery Principles of Internal Fixation Using the AO/ASIF Technique. Springer 2002. Pag. 20.
- A. Passler. Color Atlas of Dental Medicine. Thieme. 1993.